4.根据不同的类型和表现治疗

①**单纯血尿（主要）：对症治疗，定期复查血尿** VS急性肾炎:对症治疗为主(自限性疾病)

②反复发作肉眼血尿：青霉素积极控制感染；慢性扁桃体炎应切除

③伴蛋白尿和/或高血压：ACEI/ARB 将尿蛋白控制在＜0.5g/d。若无效可给泼尼松（难以控制的**蛋白尿、高血压**是预后不良的指标）

④伴肾病综合征：糖皮质激素为主

⑤伴肾衰竭-透析

⑥靶向释放剂型**布地奈德**作为在回肠末端释放的新型激素，目前已成为全球首个 IgA 肾病的靶向药

存在很多淋巴滤泡,是产生异常IgA的地方

轻中度克罗恩病局部病变,先用局部发挥作用的GC-布地奈德

5.鉴别诊断　VS 特发性血小板减少性紫癜ITP:紫癜不强调对称

急性肾炎	IgA 肾病	过敏性紫癜肾炎
毛细血管内增生性肾炎	多种病理变化	继发急进性肾炎、肾病综合征
IgG 沉积为主	IgA 沉积为主	IgA 沉积为主
前驱感染 1-3 周后明显血尿	前驱感染 1-3 天后明显血尿	前驱感染 1-3 周后明显或不明显血尿
C_3↓（8 周内恢复）	C_3 多正常	
原发性肾小球疾病	原发性肾小球疾病	疾病特征：**双下肢对称出血点**

必备且突出　单纯血尿　与循环免疫复合物有关　紫癜-皮肤出血点

八、慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）

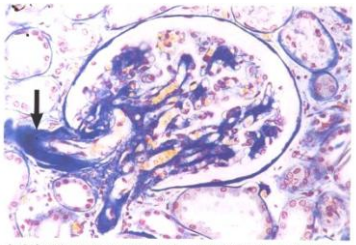
纤维化-硬

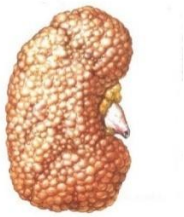
1.各种肾小球疾病最终可发展为慢性肾小球肾炎。系膜毛细血管性肾炎进展较快、膜性肾病进展较慢

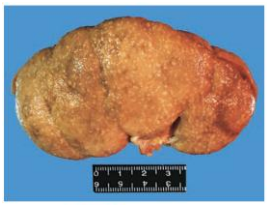
2.病理

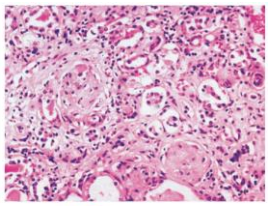
①大量肾小球**纤维化**，可有肾小球集中现象，**淋巴细胞和浆细胞**浸润 VS原发性高血压-原发性颗粒性固缩肾

②**继发性高血压**：细小动脉**玻璃样变性**，**继发性颗粒性固缩肾**（**双肾对称缩小**、表面弥漫细颗粒状）


小动脉硬化：入球小动脉和出球小动脉玻璃样变；苯胺蓝染色




图 13-23　慢性肾小球肾炎


图 13-24　慢性肾小球肾炎
肾小球玻璃样变和硬化，肾小管萎缩。间质纤维增生，炎症细胞浸润。

VS 慢性肾盂肾炎-强调不对称(一侧肾缩小/双肾不对称缩小)

3.临床表现 青壮年男性常见

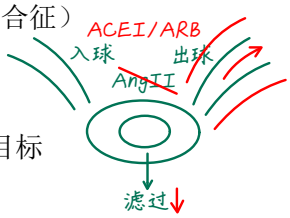
①起病缓慢而隐匿，呈慢性肾炎综合征（＞3 个月）、可急性发作（急性肾炎综合征）

②**B 超示双肾体积早期正常、后期对称性缩小（长径＜10cm）**

纤维收缩

考法①直接告诉慢性病程②不告诉慢性病程,告诉双肾对称缩小

③B超双肾体积正常时不能忽略慢性肾炎(早期)



4.治疗：**延缓**肾功能恶化和防止心脑血管并发症为主，**不**以消除肾炎综合征为目标

①利尿消肿：氢氯噻嗪（但 GFR＜30 换呋塞米）

②控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB**，但**血肌酐＞265 禁用**，目标收缩压**＜120**mmHg、**尿蛋白＜1**g/d

③限钠（＜5g/d）、限水、**限磷**、**限蛋白**、限脂、限药（如氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药）

④**保证热量，防止负氮平衡**

⑤**不**推荐积极用糖皮质激素+环磷酰胺

A.慢性肾小球肾炎
B.CKD慢性肾脏病
C.慢性肾衰竭
} 病程不同